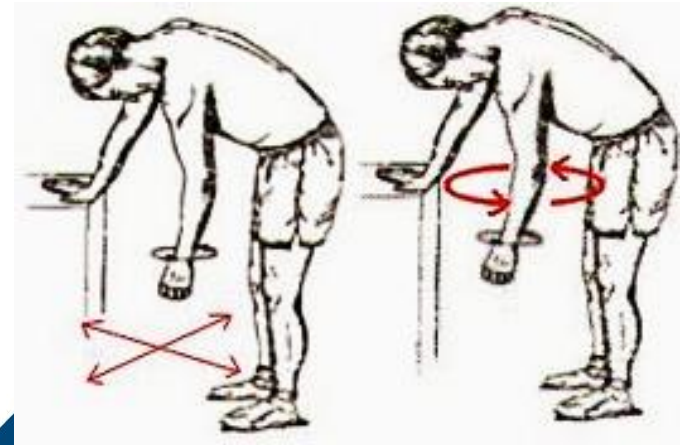


ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 14

EJERCICIO TERAPÉUTICO PENDULAR



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

EJERCICIOS DE CODMAN, SPERRY Y CHANDLER

- Consisten en realizar movimientos pendulares de los miembros superiores que penden libremente, sin generarse ninguna acción muscular en el hombro dado que el desplazamiento de la extremidad. Es el resultado del balanceo suave y rítmico del tronco.
- Fisiológicamente la fuerza de gravedad separa el húmero de la fosa glenoidea, ayudando a disminuir el dolor por medio de una tracción suave y movimientos oscilantes, lo que proporciona el movimiento de las estructuras articulares y el líquido sinovial.
- Utilizados como estrategia principal en pacientes que presentan hombro doloroso y que cursan por una etapa aguda.



PRINCIPIOS

EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE

LA POSICIÓN DEL FISIOTERAPEUTA

LA CONFIANZA POR PARTE DEL USUARIO

EL RESPETO POR EL DOLOR Y LOS CRITERIOS DE
PROGRESIÓN

EFFECTOS

SOBRE EL TEJIDO MUSCULAR

Modificaciones de longitud, permitiendo mantener las características mecánicas y la función neuromuscular. La movilización pasiva de una articulación pone en estado de acortamiento los músculos agonistas e impone un estiramiento de los músculos antagonistas.

A NIVEL DEL SISTEMA NERVIOSO

La sensibilidad propioceptiva informa sobre las posiciones y los movimientos de los múltiples eslabones corporales, unos respecto de los otros. Este conjunto de informaciones diferenciadas contribuye a la elaboración del esquema corporal y del esquema espacial

A NIVEL ARTICULAR

La movilización articular activa los receptores, a través de la información que proviene de la articulación, ayudando a mantener las propiedades mecánicas de la capsula articular y los ligamentos

EN EL SISTEMA INTEGUMENTARIO

Se produce acción directa en la piel del paciente. La movilización pasiva articular, para efectuarse en toda la amplitud, no puede estar limitada por un tejido cutáneo sin unas optimas propiedades elásticas, así que estos movimientos pueden contribuir, de forma profiláctica, a mantener las flexibilidad y movilidad de la piel de la zona comprometida.

TÉCNICA DE LOS EJERCICIOS DE CODMAN

Para la ejecución de estos ejercicios el usuario debe estar en posición bípeda, con el tronco flexionado a 90°, el miembro superior afectado pende hacia abajo en una posición entre los 60 y 90 grados de flexión.

El movimiento pendular o balanceo del brazo se inicia haciendo que el paciente mueva el tronco ligeramente hacia atrás y hacia delante, y consecutivamente hacia los lados



Figura 2. Representación gráfica de los movimientos pendulares de Codman.
Flexión y extensión



Figura 3. Representación gráfica de los movimientos pendulares de Codman.
Abducción y aducción

TÉCNICA EJERCICIOS DE CODMAN

Se pueden hacer movimientos de flexión, extensión, abducción horizontal, aducción y circunducción para así aumentar el arco de movilidad a tolerancia



Figura 4. Representación gráfica de los movimientos pendulares de Codman.
Circunducción

TÉCNICA EJERCICIOS DE SPERRY

A medida que avanza la fase de intervención se puede adicionar un peso a la mano, de forma que se provoque mayor fuerza de tracción de la articulación gleno-humeral

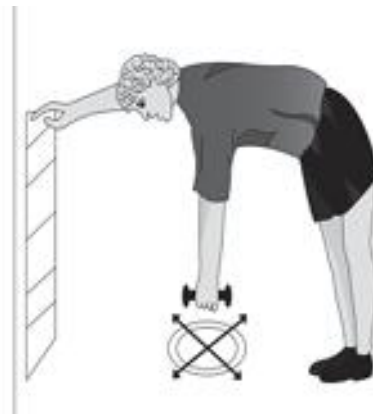


Figura 5. Representación gráfica de los movimientos pendulares de Codman.
Con peso

TÉCNICA EJERCICIOS DE CHANDLER

Decúbito prono. Colocará el brazo por fuera de la camilla, y con un peso de 1 a 2,5 Kg, colgando en la parte distal.

Si el paciente hace en casa estos ejercicios se le puede recomendar que cuando los haga con peso coja la plancha para realizarlos. Se pedirá al paciente realizar una flexo-extensión de hombro a modo de péndulo, dejándose llevar por la inercia del inicio del movimiento. Al igual que en los ejercicios de Codman, se trabajará en un arco de movimiento no doloroso que se irá incrementando según tolerancia.



CONSIDERACIONES

- Es importante saber que la ejecución de esta técnica no debe causar exacerbación del dolor y si lo causa se debe suspender su ejecución, ya que es un indicativo de mala práctica
- Cuando el paciente no es capaz de mantener el equilibrio inclinado hacia adelante, se puede aferrar a un objeto sólido o acostarse boca abajo. Si el paciente experimenta dolor de espalda la mejor opción es ubicarlo en decúbito prono.
- Solo se debe utilizar carga cuando las maniobras conjuntas de estiramiento se indican al final de la fase aguda y crónica, y solo si la escápula es fijada por el fisioterapeuta o un cinturón colocado alrededor del tórax y la escápula
- Cuando se decide agregar peso se debe tener en cuenta no sobrepasar un peso mayor a cinco libras con el fin de generar una tracción que no cause daño, lesión en el hombro o exacerbación del dolor
- **Los principios de esta técnica son:** el posicionamiento del paciente, la posición del fisioterapeuta, la confianza por parte del usuario, el respeto por el dolor y los criterios de progresión.







GRACIAS POR SU ATENCIÓN